ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19)

Coordenadorias dos blocos de Atenção Básica e Média Complexidade

Superintendência de Saúde

Vigilância em Saúde

SUMÁRIO
2020

1. INTRODUÇÃO
2. OBJETIVO GERAL
3. OBJETICOS ESPECÍFICOS
4. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO PLANO
5. ATIVIDADES POR NÍVEIS DE RESPOSTA
    A. ALERTA
    A.1 – GESTÃO
    A.2 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
    A.3 – ATENÇÃO A SAÚDE
    B. PERIGO EMINENTE
    B.1 – GESTÃO
    B.2 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
    B.3 – ATENÇÃO A SAÚDE
    C. EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA (CENARIOS I E II)
    C.1 – GESTÃO
    C.2 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
    C.3 – ATENÇÃO A SAÚDE
6. CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE (COE PARACAMBI COVID-19)
7. PÓLOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTOS ÀS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS NO ÂMBITO MUNICIPAL
8. ORIENTAÇÃO/ALTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL E DEMAIS MEDIDAS DE CONTROLE
9. ANEXOS

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição da República.

Considerando o decreto do governo do estado do rio de janeiro n° 46.973 de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do estado do rio de janeiro em razão do contágio e adota medidas enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid-19), e dá outras providências;

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde N° 188 de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

Considerando as definições de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

Considerando o Decreto Municipal N° 5074 de 17 de março de 2020 que "Reconhece a situação de emergência na saúde pública do município de Paracambi em razão ao risco de contágio em massa e adota medidas enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências";

Apresenta o Plano Municipal de Contingência para Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19)

1. Introdução

O Coronavírus é uma família de vírus que podem causar infecções respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012. Em 31 de dezembro de 2019, o Escritório da Organização Mundial de Saúde na China foi informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida, detectados na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Em 7 de janeiro de 2020, foi

identificado e caracterizado que o agente etiológico, até então desconhecido, tratava-se de uma nova espécie de Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que provoca a doença chamada COVID-19. A partir desse cenário, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e o Brasil, em 03 de fevereiro de 2020, declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a necessidade de respostas rápidas através da Portaria MS/GM Nº 188. As medidas adotadas pela Vigilância à Saúde do Brasil e outros órgãos como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tomam como base as orientações da OMS e podem ser modificadas de acordo com a evolução dos estudos científicos publicados referente à epidemia por esse novo Coronavírus. No Brasil, em 25/02/20, foi confirmado o primeiro caso do COVID-19 no estado de São Paulo, em um brasileiro procedente da Itália. Diante desse cenário, uma série de ações vem sendo adotadas em todo o mundo para definir o nível de resposta e a estrutura de comando correspondente a ser configurada, em cada nível de gestão e atenção. Este plano propõe diretrizes orientadoras para prevenção e controle de situações de risco, bem como o enfretamento da ocorrência de casos de infecção associados ao Coronavírus no município de Paracambi. No plano estão descritos os seus componentes, objetivos e as atividades por componente, considerando a sequência lógica dos eventos envolvidos para alcançar os efeitos finais.

1.1 – Modo de Transmissão

A Transmissão dos Coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como: gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Os Coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe.

1.2 – Período de Incubação

O período médio de incubação da infecção por Coronavírus é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 14 dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados é em média de 07 dias após o início dos sintomas. No

entanto, dados preliminares do COVID-19 sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

1.3 – Manifestação Clínica/Sintomas

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o Coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença.

Os principais são sintomas conhecidos até o momento são:

Febre.
Tosse.
Dificuldade para respirar
Congestão Nasal
Dor de garganta
Dor de cabeça
Prostação
Mialgia

1.4 – Grupos de Risco

Idosos, acima de 60 anos.
Crianças menores de 6 meses
Portadores de afecções respiratórias (DPOC, Asma entre outras crônicas)
Pacientes imunodeprimidos e fazendo uso de corticóide terapia.
Gestantes.

2. OBJETIVO GERAL

Descrever as ações e as estratégias de preparação, precaução, prevenção, proteção e prontidão, a fim de conter e mitigar os impactos da introdução da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) na população paracambiense.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas.

Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna;

Identificação e Monitoramento de casos em isolamento domiciliar;

Garantir adequada assistência, com garantia de acesso e manejo clinico adequado;

Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus;

Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos;

Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de saúde;

Intensificar ações de triagem e resposta rápida e efetiva aos casos suspeitos;

Disponibilizar ações de promoção e prevenção em saúde;

Combater a desinformação através de mídia social e grupos de trabalho;

Organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado atendimento da população Paracambiense à rede de saúde.

4. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO PLANO

Este plano foi estruturado em níveis de resposta, baseado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) com adaptações locais, de forma que toda ação deve ser proporcional e restrita aos riscos avaliados e cenários epidemiológicos existentes.

4.1 - Definição dos níveis de resposta:

A. Nível de resposta: **Alerta:** Corresponde a uma situação em que há casos suspeitos em Paracambi, de acordo com a definição da SES RJ.

B. Nível de resposta: **Perigo Eminente**: Corresponde a uma situação em que há caso confirmado importado em Paracambi, ou seja, sem transmissão local.

C. Nível de resposta: **Emergência de Saúde Pública.**

Cenário I - Corresponde a uma situação em que há caso confirmado autóctone em Paracambi, ou seja, com transmissão local.
Cenário II – Transmissão local comunitária/sustentada quando houver casos autóctones confirmados sem vínculo, com contato próximo ou domiciliar.

4.2 - DEFINIÇÃO DO CASO SUSPEITO

Situação 1: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de locomoção para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Situação 2: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus (COVID-2019), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Situação 3: Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de coronavírus (COVID-2019) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

5. ATIVIDADES POR NÍVEIS DE RESPOSTA

A: ALERTA

A.1 – Gestão

1. Instalar o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Paracambi COVID-19) em caráter temporário;

2. Manter atualizados os contatos da equipe que irá compor o COE COVID-19
3. Identificar fontes de equipamentos e recursos adicionais para a realização das ações atribuídas à secretaria de saúde para a execução do plano
4. Articular áreas estratégicas para verificação dos insumos necessários para o enfrentamento da doença;
5. Promover estratégias eficientes de educação permanente para os profissionais da rede de saúde no município;
6. Direcionar estratégias de comunicação de massa.

A.2 – Vigilância em Saúde

1. Sensibilizar os profissionais de saúde da rede pública e privada de Paracambi para a notificação imediata de casos suspeitos, de acordo com a definição de caso vigente, estabelecida pela SES RJ;
2. Realizar busca ativa em unidades de saúde municipal e privada com enfoque no Coronavírus diariamente;
3. Investigar os rumores e os casos potencialmente suspeitos notificados pelas unidades de saúde para verificar se atendem à definição de caso suspeito estabelecida pela SES RJ;
4. Capacitar os profissionais da rede de saúde municipal e privada sobre os sinais e sintomas da doença, medidas de prevenção e controle, notificação, investigação, bem como atualizá-los sobre o cenário epidemiológico nacional e mundial;
5. Atualizar sala de situação diariamente com cenário epidemiológico, para subsidiar a tomada de decisão;
6. Estabelecer ações para notificação precoce dos casos suspeitos e confirmados a SES e a CIEVES;
7. Encaminhar amostras coletadas, de forma oportuna, ao laboratório de referência – Lacen;
8. Elaboração, distribuição e divulgação de protocolos operacionais de vigilância do Novo Coronavírus – Covid 19
9. Atualização dos dados epidemiológicos do município;
10. Avaliar e orientar Unidades e Estabelecimentos, do risco da disseminação do vírus;
11. Sistematizar ações intersetoriais no intuito de fortalecer ações de identificação precoce, manejo clínico e prevenção ao Covid 19;
12. Encerrar oportunamente casos negativos ou positivos para Covid 19;

15. Estabelecer ações em praça pública no intuito de oferece informações à população sobre medidas preventivas mediante as formas de transmissão do COVID-19;
16. Subsidiar o setor de comunicação visual na produção e publicação de materiais pertinentes ao COVID-19;
17. Intensificar ações de acolhimento e classificação de risco no Hospital Municipal;
18. Definir atendimento específico no Hospital Municipal aos casos de IRAs (Infecções Respiratórias Agudas) no intuito de qualificar e aumentar o efeito de resposta aos casos suspeitos;
19. Capacitação recorrente de equipe multiprofissional no que se diz respeito às ações de prevenção;
20. Dispor de leitos de isolamento respiratório no Hospital Municipal;
21. Dispor de ventiladores mecânicos e equipamentos de monitoramento para suporte a casos de Insuficiência Respiratória no Hospital Municipal;
22. Estabelecer fluxo de coleta, em tempo oportuno, para encaminhar ao laboratório de referência estadual (LACEN RJ);
23. Estabelecer no Hospital Municipal fluxo de atendimento com manejo e conduta aos casos suspeitos e cronificados;
24. Disponibilização de transporte, urgência e emergência, em casos onde haja necessidade de regulação oportuna do paciente;
25. Estabelecer fluxo de referência às unidades de suporte da região (Hospital universitário de Vassouras e Hospital Nossa Senhora da conceição – Três Rios) – Leitos de UTI – Isolamento;
26. Dispor as equipes do Serviço Móvel de Urgência - SAMU e Transporte Sanitário com insumos e EPIs necessários à assistência;

B: PERIGO EMINENTE

Intensificar todas as ações anteriores e:

B.1 – Gestão

1. Convocar reunião, sempre que se fizer necessário para alinhamento da resposta integrada ao enfrentamento da COVID-19;

A.3 – Atenção à Saúde

1. Elaborar e divulgar o fluxo de atendimento e de isolamento hospitalar e domiciliar dos casos suspeitos para atenção primária, Hospital e de atendimento móvel de urgência;
2. Definir protocolo do meio de transporte de pacientes para a rede de referência Estadual;
3. Capacitar os profissionais da rede de saúde municipal sobre a COVID-19;
4. Reforçar medidas de precaução para as profissionais e pacientes;
5. Reforçar a aplicação dos protocolos de desinfecção e limpeza de salas e equipamentos das unidades de saúde e transportes de pacientes;
6. Providenciar a aquisição e distribuição de todos os insumos, como sabão líquido, papel toalha, álcool gel e equipamentos de proteção individual (EPI), para abastecer e reforçar a rede de saúde;
7. Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes;
8. Capacitação dos profissionais da Atenção Básica para identificação precoce e manejo adequado aos casos suspeitos;
9. Monitoramento de grupos específicos de doenças crônicas (portadores de HAS, DIA, DPOC entre outras patologias);
10. Realização sistemática de ações de promoção e prevenção à saúde na atenção primária;
11. Disponibilizar às Unidades de Saúde, protocolos disponíveis de definição de caso, medidas de vigilância e fluxos assistenciais;
12. Efetivar as ações domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde no intuito de ampliar as ações de promoção e prevenção em Saúde, com especificidade ao enfrentamento ao COVID-19;
13. Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde no tocante a identificação precoce de casos suspeitos e efetivar elo de referência do paciente aos serviços de saúde.
14. Disponibilizar ações de capacitação a todos os profissionais da rede no intuito de qualificar as ações mediante o enfrentamento ao COVID-19;

1. Atender e executar o protocolo interno de assistência a casos suspeitos e medidas de isolamento na unidade, até a transferência para a referência, quando necessário por meio da central de regulação de leitos do Estado;
2. Disponibilizar o transporte de pacientes graves suspeitos de COVID-19 à referência estadual;
3. Notificar imediatamente o caso suspeito ao Cievs RJ;
4. Realizar a desinfecção e limpeza de salas e equipamentos das unidades de saúde; e transportes de pacientes, segundo protocolos;
5. Garantir a continuidade do abastecimento de insumos como sabão líquido, papel toalha, álcool gel e EPI na rede de saúde municipal;
6. Monitorar, rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme aumento da demanda de medicamentos sintomáticos para COVID-19;

C. Nível de resposta: Emergência de Saúde Pública (Cenários I e II)

Intensificar todas as ações anteriores e:

C.1 – Gestão

1. Garantir a atuação do CMRR COVID-19 e realizar reunião semanal de forma com todos os envolvidos no enfrentamento da COVID-19, a partir do Cenário I;
2. Avaliar a necessidade de ampliar os horários de funcionamento do CMRR COVID-19, considerando a necessidade de funcionamento 24h horas por dia nos 7 dias da semana;
3. Prover mecanismos para expansão de serviços de saúde e ampliação do atendimento, identificando as estratégias viáveis;
4. Manter a rede atualizada sobre protocolos clínicos e medidas de prevenção;
5. O CMRR COVID-19 deve alertar imediatamente ao chefe do poder executivo municipal, Cenário de Emergência de Saúde Pública para subsidiar tomada de decisão;

2. Prover meios para a garantia da continuidade das atividades do plano, no nível de perigo iminente;
3. Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais para garantia das ações em caráter emergencial;
4. Manter permanente articulação com a Gestão Estadual para apoio mútuo quanto ao fluxo dos pacientes às Unidades de Referência, bem como para a execução do plano de contingência municipal;
5. Articular ações de comunicação assertiva de risco para prevenir crises sociais, de mídia, econômicas e até políticas decorrentes da transcendência do evento e, consequentemente, pânico da população e dos profissionais da rede de serviços assistenciais públicos e privados diante do cenário epidemiológico da COVID-19;
6. Ampliar a publicidade das informações sobre COVID-19 para a população, profissionais de saúde, e a imprensa;

B.2 – Vigilância em Saúde

1. Alertar ao gestor sobre a mudança no cenário epidemiológico e o nível de resposta ativado;
2. Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou até o descarte para a COVID-19, diariamente;
3. Realizar levantamento de contatos dos casos notificados para monitoramento;
4. Realizar monitoramento de casos suspeitos e confirmados, através de contatos telefônicos e visitas em loco;
5. Monitorar os contatos dos casos suspeitos, diariamente, durante o período de incubação (14 dias) ou até o descarte para COVID-19 do caso índice;
6. Processar os registros de casos suspeitos e de contatos;
7. Monitorar e/ou realizar coleta de amostras biológicas para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos sintomáticos, de acordo com as definições de caso vigentes estabelecidas pela SES RJ;
8. Monitorar o seguimento da amostra para o laboratório de referência (LACEN RJ) até a liberação do resultado;

B.3 – Atenção à Saúde

C.2 – Vigilância em Saúde

1. Alertar ao gestor sobre a mudança no cenário epidemiológico e o nível de resposta ativado;
2. Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou até o descarte para COVID-19, residentes em área descoberta da Estratégia de Saúde da Família (ESF);

C.3 – Atenção à Saúde

1. Garantir a notificação de novos casos suspeitos;
2. Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou até o descarte para COVID-19, residentes em área coberta pela Estratégia de Saúde da Família e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde;
3. Avaliar a capacidade e qualidade dos atendimentos no Hospital Municipal, indicando a necessidade ou não da ampliação dos atendimentos;
4. Manter o monitoramento da logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme aumento da demanda de medicamentos sintomáticos para COVID-19;

6.Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Paracambi COVID-19)

O COE Paracambi, instituído no prédio da Policlínica Municipal, que fica situado à Avenida dos Operários,s/n - Centro/Paracambi/RJ, com atendimento preferencial por telefone, 21 – 2683 0187 – ou endereço digital coepbicovid19@gmail.com , tem por objetivo específico esclarecer as dúvidas mediante o tema, Covid 19 e referenciar possíveis casos sintomáticos à rede assistencial e pólos de atendimento específico às Infecções Respiratórias Agudas (IRAs).

7.Pólos municipais de atendimentos às Infecções Respiratórias Agudas no âmbito municipal

Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça, situado Av. Jonas Leal, 16 – Lages – Paracambi/RJ, telefone: 21 – 2683 3597.

Policlínica Municipal de Paracambi, situada a Avenida dos Operários,s/n - Centro – Paracambi/RJ, telefone: 21 – 2683 0187.

8. ORIENTAÇÃO/ALTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL E DEMAIS MEDIDAS DE CONTROLE

Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal)

1. Suspensão de consultas ambulatoriais e eletivas no intuito de evitar aglomerados de pessoas;
2. Permanência da equipe assistencial direta (médicos, enfermeiros entre outros) para identificação precoce dos casos suspeitos;
3. Suspensão de agendas eletivas de Odontologia, assegurando a assistência em episódios de urgência (dor, entre outros);

Média e Alta Complexidade (Policlínica, Fisioterapia, Sáude da Mulher, Centro de Imagens, Central de Regulação, Laboratório e Rede de Saúde Mental

1. Suspensão das agendas ambulatoriais para evitar aglomerado de pessoas;
2. Manutenção dos profissionais médicos nas Unidades no intuito de atender especificamente pacientes com doenças crônicas e identificação de casos suspeitos;
3. Suspender exames ambulatoriais com exceção de casos específicos (doentes crônicos – Cardíacos e Oncológicos);
4. Intensificar ações de acolhimento na Central Municipal de Regulação, para identificação de casos urgentes (procedimentos regulatórios);
5. Intensificar ações de coleta domiciliar, principalmente a pacientes idosos e portadores de doenças crônicas;
6. Suspensão do ambulatório de Fisioterapia e intensificar as ações à nível domiciliar;
7. Suspensão das atividades coletivas, no âmbito da Saúde Mental, que configurem aglomerado de pessoas;
8. Priorizar as estratégias de atenção à crise, nos Centros de

Atenção Psicossocial, ou nos domicílios, assim como os cuidados com os moradores dos serviços residenciais terapêuticos;

9. Reorganizar as ofertas coletivas da assistência em função das necessidades atuais. Neste sentido, recomendamos que não sejam priorizados ações de cuidado em grupo ou/e em lugares fechados;
10. Proteger os usuários e profissionais do potencial risco de contaminação, elaborando estratégias de acompanhamento a distância, redução de reuniões e priorização da comunicação eletrônica (contato telefônico e outros);
11. Manutenção de equipe multiprofissional nos dispositivos de saúde mental, no intuito de prestar assistência específica a identificação precoce de possíveis e manejo clínico e prestar também apoio em saúde metal, tanto para profissionais de saúde quanto para a população em geral;
12. Suspensão dos ambulatórios de saúde mental, com manutenção dos médicos nas unidades, para atendimento ao surto psíquico.

Média e Alta Complexidade (Hospital Municipal)

1. Restrição de visitas aos pacientes;
2. Intensificar ações de acolhimento e classificação de risco;
3. Definir atendimento específico aos casos de IRAs (Infecções Respiratórias Agudas) no intuito de qualificar e aumentar o efeito de resposta aos casos suspeitos;
4. Estabelecer insumos e EPIs aos profissionais;
5. Qualificar as ações de Vigilância na unidade no intuito de identificação e notificação precoce dos casos suspeitos;
6. Capacitação recorrente de equipe multiprofissional no que se diz respeito às ações de prevenção;
7. Dispor de ventiladores mecânicos e equipamentos de monitoramento para suporte a casos de Insuficiência Respiratória;
8. Estabelecer fluxo de coleta, em tempo oportuno, para encaminhar ao laboratório de referência estadual (Lacen);
9. Estabelecer na unidade fluxo de atendimento com manejo e conduta aos casos suspeitos e cronificados;
10. Diminuir o fluxo, sempre que possível, de internação hospitalar no intuito de liberação de leitos;
11. Disponibilização de transporte, urgência e emergência, em casos onde haja necessidade de regulação oportuna do paciente;

12. Estabelecer fluxo de referência às unidades de suporte da região (Hospital universitário de Vassouras e Hospital Nossa Senhora da conceição – Três Rios) – Leitos de UTI – Isolamento.

Média e Alta Complexidade (SAMU)

1. Dispor de ventiladores mecânicos e equipamentos de monitoramento para suporte a casos de Insuficiência Respiratória;
2. Estabelecer fluxo de coleta, em tempo oportuno, para encaminhar ao laboratório de referência estadual (Lacen);
3. Estabelecer na unidade fluxo de atendimento com manejo e conduta aos casos suspeitos e cronificados;
4. Disponibilização de transporte, urgência e emergência, em casos onde haja necessidade de regulação oportuna do paciente;
5. Estabelecer fluxo de referência às unidades de suporte da região (Hospital universitário de Vassouras e Hospital Nossa Senhora da conceição – Três Rios) – Leitos de UTI – Isolamento.

Vigilância Epidemiológica

1. Estabelecer ações para notificação precoce dos casos suspeitos e confirmados a SES e a CIEVES;
2. Realizar monitoramento de casos suspeitos e confirmados, através de contatos telefônicos e visitas em loco;
3. Encaminhar amostras coletadas, de forma oportuna, ao laboratório de referência – Lacen;
4. Elaboração, distribuição e divulgação de protocolos operacionais de vigilância do Novo Coronavírus – Covid 19
5. Atualização dos dados epidemiológicos do município;
6. Avaliar e orientar Unidades e Estabelecimentos, do risco da disseminação do vírus;
7. Sistematizar ações intersetoriais no intuito de fortalecer ações de identificação precoce, manejo clínico e prevenção ao Covid 19;
8. Encerrar oportunamente casos negativos ou positivos para Covid 19;

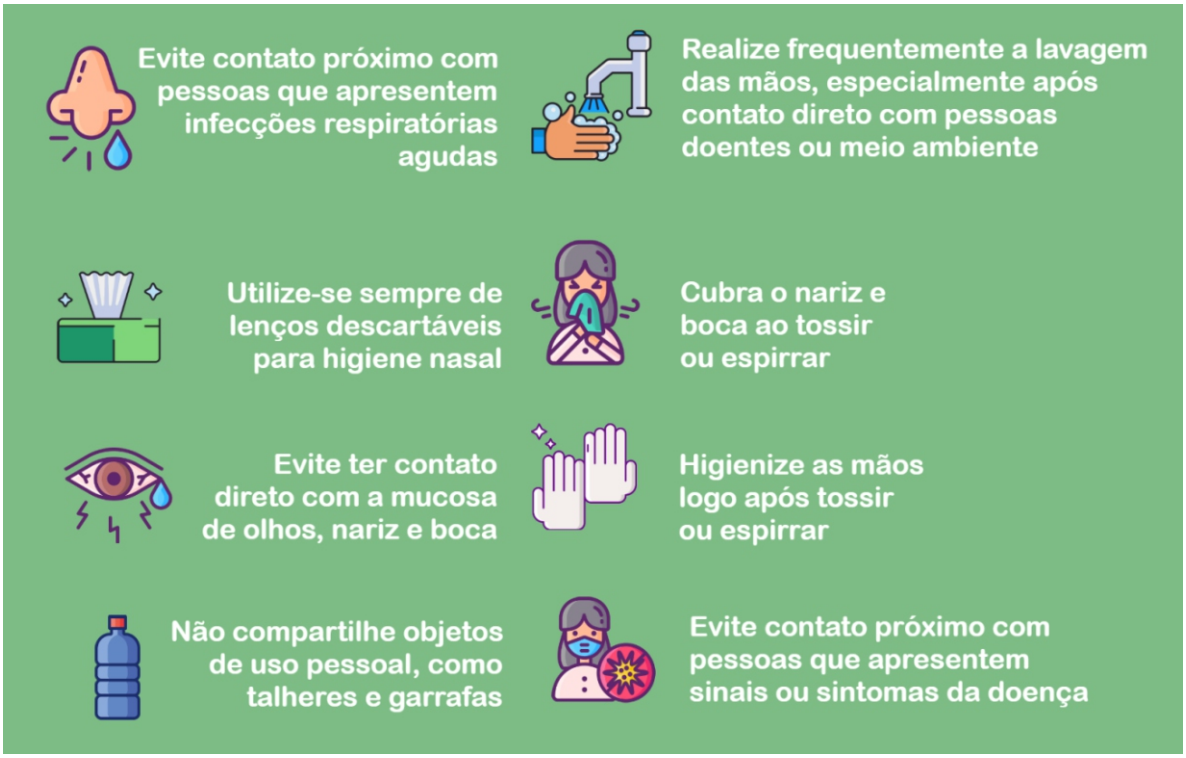
9. Busca ativa de contatos a casos suspeitos e confirmados;

10. Avaliação sistemática da informação sobre sua veracidade no intuito de enfrentamento de notícias falsas, através dos canais oficiais de comunicação municipal;

10. Subsidiar a rede de capacitações frequentes com informação atualizada e pertinente ao momento epidemiológico;

9 – ANEXOS

9.1 Medidas de Promoção e Prevenção em Saúde



Paciente SEGURO Paracambi

Higienização Simples das Mãos



1. Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia.



2. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas a superfície das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).



3. Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si.



4. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos



5. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais



6. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem.



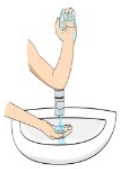
7. Esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular



8. Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular.



9. Esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando o movimento circular.



10. Enxague as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.



11. Seque as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos


COMO SE PREVENIR DO CORONAVÍRUS
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
LAVE REGULARMENTE AS MÃOS ATÉ A ALTURA DOS PUNHOS COM ÁGUA E SABÃO.
Paracambi
SECRETARIA MUNICIPAL DE Saúde
#PARACAMBI CONTRACORONAVIRUS


COMO SE PREVENIR DO CORONAVÍRUS
CUBRA O NARIZ E A BOCA AO ESPIRRAR OU TOSSIR.
Paracambi
SECRETARIA MUNICIPAL DE Saúde
#PARACAMBI CONTRACORONAVIRUS

Paciente SEGURO Paracambi

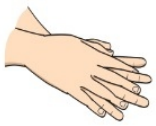
Higienização das mãos com Preparações Alcoólicas
(Gel ou Solução a 70% com 1.3% de Glicerina)



1. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).



2. Friccione as palmas das mãos entre si.



3. Friccione a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos.



4. Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados.



5. Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mao oposta (e vice-versa), segurando os dedos.



6. Friccione o polegar direito, com auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.



7. Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita (e vice-versa), fazendo um movimento circular.



8. Friccione os punhos com movimentos circulares.



9. Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

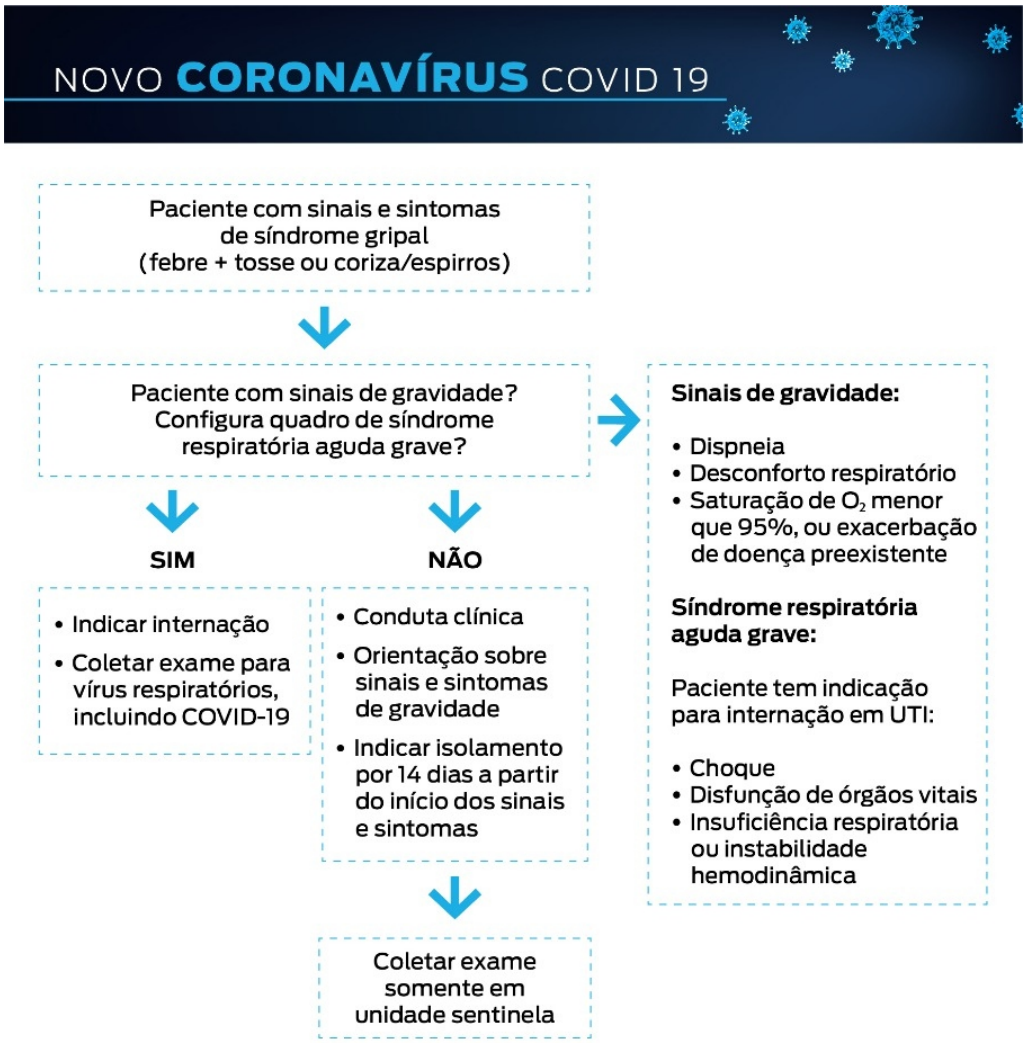
Ministério da Saúde

Paracambi
SECRETARIA MUNICIPAL DE Saúde





9.2 Protocolos Assistenciais



9.2 RECOMENDAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES DE ACORDO COM O TIPO DE SETOR, PROFISSIONAL E TIPO DE ATIVIDADE, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

REDE DE UNIDADES DA SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO			
PONTOS DE ENTRADA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA			
SETOR	**PROFISSIONAL DE ACORDO COM CADA SETOR**	**TIPO ATIVIDADE**	**TIPO DE EPI**
Recepção	Todos profissionais	Recepção de pacientes **COM** suspeita de COVID-19	- Máscara cirúrgica
Acolhimento e Classificação de Risco	Profissionais de saúde	Triagem não envolvendo contato direto.	- Máscara cirúrgica;
	Paciente **COM** sintoma respiratório	Nenhuma	- Máscara cirúrgica, se tolerada pelo paciente - Orientar etiqueta de tosse e higienização das mãos.
	Paciente **SEM** sintoma respiratório	Nenhuma	Uso de EPI de acordo com precaução padrão e avaliação de risco. **Não há necessidade de uso de EPI específico para COVID-19.**
Área de isolamento temporário	Profissionais de saúde	Assistência	- Máscara cirúrgica; - Capote impermeável; - Luvas de procedimento; - Óculos de proteção
	Paciente **COM** sintoma respiratório	Nenhuma	- Máscara cirúrgica, se tolerada pelo paciente - Orientar etiqueta de tosse e higienização das mãos.

			- Óculos de Proteção
Radiologia	Técnico de radiologia	Realização do exame em paciente **COM** suspeita/confirmado COVID-19	- Máscara Cirúrgica; - Capote Impermeável; - Luvas de Procedimento; - Óculos de Proteção
Áreas administrativas	Todos profissionais	Tarefas administrativas sem contato com paciente com suspeita /confirmado COVID-19.	**Não há necessidade de uso de EPI.**
INSTALAÇÕES AMBULATORIAIS			
SETOR	**PROFISSIONAL DE ACORDO COM CADA SETOR**	**TIPO ATIVIDADE**	**TIPO DE EPI**
Sala de espera	Paciente **COM** sintoma respiratório	Nenhuma	Máscara cirúrgica. Encaminhar imediatamente o paciente para uma sala de isolamento ou separar área longe de outras. Se não for viável, distância espacial de pelo menos 1 metro de outros pacientes.
	Paciente **SEM** sintoma respiratório	Nenhuma	**Não há necessidade de uso de EPI.**
Acolhimento e Classificação de Risco	Profissionais de saúde	Triagem não envolvendo contato direto.	- Máscara cirúrgica
	Paciente **COM** sintoma respiratório	Nenhuma	- Distância espacial de pelo menos 1 metro. - Máscara cirúrgica, se tolerada pelo paciente -Orientar etiqueta de tosse e higienização das mãos.
	Paciente **SEM** sintoma respiratório	Nenhuma	**Não há necessidade de uso de EPI.**

Consultórios	Profissionais de saúde	Exame clínico do paciente **COM** suspeita/confirmado COVID-19	- Máscara cirúrgica; - Capote impermeável; - Luvas de procedimento; - Óculos de proteção
	Profissionais de saúde	Exame clinico do paciente **SEM** suspeita/confirmado COVID-19	Uso de EPI de acordo com precaução padrão e avaliação de risco. **Não há necessidade de uso de EPI específico para COVID-19.**
	Paciente **COM** sintoma respiratório	Nenhuma	Máscara cirúrgica se tolerada pelo paciente.
	Paciente **SEM** sintoma respiratório	Nenhuma	**Não há necessidade de uso de EPI.**
	Equipe de Higiene Hospitalar	Limpeza e desinfecçao das superfícies e ambiente após consulta com	- Máscara Cirúrgica; - Capote Impermeável; - Luvas de Limpeza; - Óculos de Proteção

		paciente apresentando sintoma respiratório.	
Áreas administrativas	Todos profissionais	Tarefas administrativas	**Não há necessidade de uso de EPI.**
AMBULÂNCIA OU VEÍCULO DE TRANSPORTE (manter janelas abertas durante o transporte)			
SETOR	**PROFISSIONAL DE ACORDO COM CADA SETOR**	**TIPO ATIVIDADE**	**TIPO DE EPI**
Transporte	Profissionais de Saúde	Transporte de pacientes **COM** suspeita de COVID-19	- Máscara cirúrgica; - Capote impermeável; - Luvas; - Óculos de proteção
	Paciente **COM** suspeita de COVID -19	Durante o transporte	- Máscara cirúrgica se tolerado pelo paciente
	Motorista no transporte de pacientes **COM** suspeita de COVID-19	Transporte em veículo com compartimento isolado para o motorista	**Não há necessidade de uso de EPI.**
		Transporte sem contato direto com o paciente, quando não há separação entre o compartimento do motorista e do paciente	- Máscara cirúrgica
		Na assistência no embarque do paciente	- Máscara cirúrgica; - Capote impermeável; - Luvas de procedimento; - Óculos de proteção

RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS			
SETOR	**PROFISSIONAL DE ACORDO COM CADA SETOR**	**TIPO ATIVIDADE**	**TIPO DE EPI**
Residência terapêutica	Profissionais de Saúde ou Cuidador	Assistência com contato direto com paciente **COM** suspeita /confirmado COVID-19	- Máscara cirúrgica; - Capote impermeável; - Luvas de procedimento; - Óculos de proteção
	Profissionais de Saúde ou Cuidador	Assistência com contato direto com paciente **SEM** suspeita /confirmado COVID-19	Uso de EPI de acordo com precaução padrão e avaliação de risco. **Não há necessidade de uso de EPI específico para COVID-19.**
	Paciente **COM** suspeita/confirmado COVID -19	Nenhuma	- Máscara cirúrgica se tolerado

	Equipe de Higiene Hospitalar	Limpeza e desinfecção das superfícies e ambiente após consulta.	- Máscara Cirúrgica; - Capote Impermeável; - Luvas de Limpeza; - Óculos de Proteção
PACIENTES INTERNADOS			
SETOR	**PROFISSIONAL DE ACORDO COM CADA SETOR**	**TIPO ATIVIDADE**	**TIPO DE EPI**
Acolhimento e Classificação de Risco	Profissionais de saúde	Triagem não envolvendo contato direto.	- Máscara cirúrgica;
	Paciente **COM** sintoma respiratório	Nenhuma	- Máscara cirúrgica, se tolerada pelo paciente - Orientar etiqueta de tosse e higienização das mãos.
	Paciente **SEM** sintoma respiratório	Nenhuma	**Não há necessidade de uso de EPI.**
Unidades de Internação (Enfermaria, UTI, USI, UTI Pediátrica, UCINCo/UCINCa, Alojamento Conjunto, etc.)	Profissionais de saúde e apoio	Assistência com contato direto com paciente **COM** suspeita /confirmado COVID-19	- Máscara cirúrgica; - Capote impermeável; - Luvas de procedimento; - Óculos de proteção
		Procedimentos que geram aerossol em pacientes **COM** suspeita /confirmado COVID-19	- Máscara PFF2; - Capote impermeável; - Luvas de procedimento; - Óculos de proteção ou protetor facial; - Gorro
	Equipe de Higiene Hospitalar	Entrada no quarto de paciente **COM** suspeita /confirmado COVID-19	- Máscara Cirúrgica; - Capote Impermeável; - Luvas de Limpeza; - Óculos de proteção
	Visitante ao paciente **COM** COVID-19.	Suspensa. Situações especiais deverão ser avaliadas à critério médico.	Caso aconteça: - Máscara Cirúrgica; - Capote Impermeável; - Luvas de Procedimento - Orientar higienização das mãos.
	Visitante ao paciente **COM** COVID-19.	Suspensa. Situações especiais deverão ser avaliadas à critério médico.	Caso aconteça: - Máscara Cirúrgica; - Capote Impermeável; - Luvas de Procedimento - Orientar higienização das mãos.
Outras áreas de circulação de pacientes (enfermarias, corredores)	Profissionais de Saúde	**Nenhuma atividade desenvolvida, sem contato COM paciente com suspeita/confirmado COVID-19**	**Não há necessidade de uso de EPI.**
Laboratório	Técnico de laboratório	Manipulação de amostras respiratórias	- Máscara PFF-2; - Capote Impermeável; - Luvas de Procedimento;

*São exemplos de procedimentos que podem gerar aerossóis: intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, reanimação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasofaringeas para pesquisa de novo coronavírus e broncoscopias.

Orientações para colocação e remoção dos EPIs: Sequência para Colocar os EPIs:

1. Higienizar as mãos;
2. Capote Impermeável;
3. Luvas de Procedimento
4. Gorro (quando indicado)
5. Máscara;
6. Óculos de proteção ou Protetor Facial.

Sequência para Retirar os EPIs:

1. Luvas (com técnica adequada);
2. Capote Impermeável;
3. Higienizar as mãos;
4. Óculos de proteção ou Protetor Facial;
5. Retirar Máscara (remover pelo elástico, sem tocar na frente nem na parte interna);
6. Gorro (quando utilizado)
7. Higienizar as mãos.

Máscara cirúrgica: colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz. Substituir a máscara usada por uma nova máscara se esta se tornar úmida. Remover a máscara pela parte de trás, sem tocar na frente. Higienizar as mãos após a remoção Máscara de proteção respiratória: ajustar corretamente à face. Luvas: antes de calçar as luvas, deve ter sido previamente realizada higienização das mãos. Não tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas. O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. Higienizar as mãos após a retirada das luvas. Ter atenção à técnica de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos.

Óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto): devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a limpeza e desinfecção após o uso. Capote Impermeável: O capote ou avental deve ser impermeável, ter mangas

longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Deve ser removido e descartado após a realização de procedimentos e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência.